Kemenkes

RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)

DIREKTORAT IMUNISASI 2025-2029



Kata Pengantar



Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Imunisasi 2025-2029 telah diselesaikan dengan baik.

Rencana Aksi Kegiatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dalam rangka memperkuat transformasi kesehatan. Dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program sehingga upaya meningkatkan pengelolaan imunisasi dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur.

Dalam proses penyusunan rencana aksi kegiatan ini telah melibatkanseluruh tim kerja Direktorat Imunisasi dan ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalan penyusunan dokumen RAK ini.

Selanjutnya untuk seluruh pemangku kepentingan agar menggunakan dokumen RAK ini sesuai keperluannya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 31 Desember 2025

dr. Indri Yogyaswari, M.A.R.S

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **iv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Kondisi Umum 1
1.2 Potensi dan Permasalahan 3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN **5**
2.1 Visi 5
2.2 Misi 5
2.3 Tujuan 6
2.4 Sasaran Strategis 6
2.5 Manajemen Risiko 7
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN **15**
3.1 Arah Kebijakan 15
3.2 Strategi 15
3.3 Kerangka Regulasi 16
3.4 Kerangka Kelembagaan 17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN **19**
4.1 Target Kinerja 19
Rumusan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Imunisasi Tahun 2025– 2029 20
1. Cakupan imunisasi MR 1 pada bayi 20
2. Cakupan imunisasi antigen baru 21
3. Cakupan imunisasi HPV 21
4. Cakupan imunisasi lengkap pada baduta 22
5. Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar 22
6. Cakupan status imunisasi T2+ pada Wanita Usia Subur (WUS) 22
7. Kabupaten/kota yang mencapai target kinerja surveilans PD3I 23
4.2 Kerangka Pendanaan 25
BAB V PENUTUP **26**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Risk Register Direktorat Imunisasi
Tabel 1. 2 Target dan Indikator Kinerja Direktorat Imunisasi tahun 2025-2029
Tabel 1. 3 Indikasi Pendanaan Direktorat Imunisasi Tahun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar Grafik

Grafik 1. 1 Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Menurut Karakteristik, 2022–2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Matriks Kerangka Pendanaan

Lampiran 1 Matriks Kerangka Regulasi Program

Lampiran 3 Definisi Operasional (DO) dan Cara Perhitungan

Lampiran 4 Tim Penyusun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

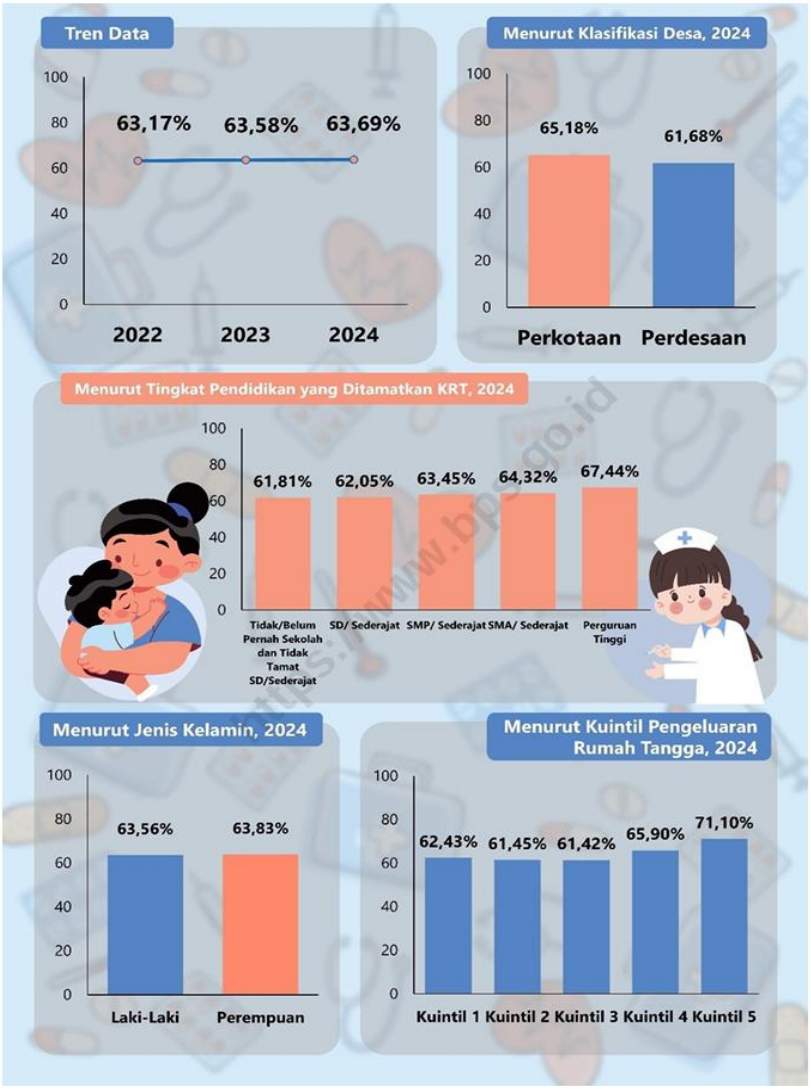
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Imunisasi hingga saat ini masih diakui sebagai salah satu bentuk intervensi perlindungan sekaligus pencegahan penyakit menular yang paling efektif dan efisien. Perlindungan yang diberikan bukan hanya untuk individu yang mendapatkan imunisasi saja, melainkan juga memberikan kekebalan bagi orang-orang yang ada di sekitar individu tersebut. Menyesuaikan kebijakan perluasan imunisasi secara nasional terhadap tiga antigen baru, yaitu PCV, Rotavirus dan HPV dalam periode RPJMN 2019-2024 ditetapkan 6 (enam) indikator capaian Program Imunisasi yang harus dicapai pada akhir 2024. Indikator tersebut terdiri atas 1 (satu) indikator RPJMN, 1 (satu) indikator IKP (Indikator Kinerja Program) dan 5 (lima) indikator IKK (indikator Kinerja Kegiatan).

Grafik 1. 1 Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Menurut Karakteristik, 2022–2024



Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Menurut Karakteristik, 2022–2024. Sumber: Profil Kesehatan Ibu dan Anak, BPS. 2024.

Indikator RPJMN tahun 2019-2024 untuk program imunisasi adalah persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan dengan target sebesar 75%. Berdasarkan hasil survei BPS,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

capaian indikator tersebut pada tahun 2024 hanya mencapai 63,7%. Angka ini tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang menyebutkan bahwa capaian imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan sebesar 56,1%. Sementara untuk Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin hanya mencapai 70,6% dari target 85%.

Selain indikator yang disebutkan di atas, terdapat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terdiri dari cakupan Imunisasi bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap, cakupan imunisasi anak usia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta, cakupan anak bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru, cakupan anak yang mendapat imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar, dan cakupan wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2. Berdasarkan laporan program indikator anak yang mendapat imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar telah mencapai target sebesar 91,6% dari target 90%. Indikator Kinerja Kegiatan Lainnya tidak mencapai target.

Penurunan capaian imunisasi mengakibatkan meningkatnya kasus PD3I dan bahkan terjadinya kejadian luar biasa (KLBPD3I) di beberapa wilayah: 53 KLB Campak di 37 Kako pada 16 provinsi, 1 KLB Rubella di 1 kabupaten, 6 kasus VDPV2 di 6 kako padai 5 provinsi, 131 KLB difteri di 89 kako pada 25 provinsi, 43 kasus tetanus di 33 kako pada 22 provinsi. 944 kasus pertusis din 144 kako pada 27 provinsi. Peningkatan kasus dan KLB PD3I tentunya akan meningkatkan resiko tidak tercapainya target eradikasi polio dan eliminasi Campak-Rubella pada tahun 2026, resiko tidak berhasil mempertahankan status Indonesia Bebas Polio yang telah dicapai sejak 2014, resiko tidak berhasil mempertahankan eliminasi Tetanus Neonatorum (TN) yang telah dicapai sejak 2016.

Bercermin dari pencapaian target indikator periode sebelumnya, di RPJMN tahun 2025-2029 pemerintah menggunakan indikator imunisasi bayi lengkap dan indikator cakupan imunisasi HPV. Sebagai turunan dari indikator RPJMN digunakan indikator imunisasi bayi lengkap dan cakupan imunisasi 14 antigen sebagai Indikator Kinerja Program (IKP). Penggunaan kedua indikator tersebut secara simultan memungkinkan pengukuran kinerja program yang lebih utuh dan berimbang, mencakup dimensi akses, pemerataan dan kualitas hasil layanan. Kedua IKP diperkuat oleh 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK yang dimaksud adalah cakupan imunisasi MR1, kabupaten/kota yang mencapai kinerja surveilans PD3I, cakupan antigen baru, cakupan imunisasi lengkap baduta, cakupan imunisasi anak usia sekolah dasar, cakupan imunisasi HPV, dan cakupan imunisasi T2 pada Wanita Usia Subur (WUS). Dibandingkan periode sebelumnya, ada indikator baru yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja kegiatan yaitu cakupan imunisasi MR1 dan cakupan imunisasi HPV. Cakupan imunisasi MR1 digunakan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dapat menggambarkan kontinuitas pelayanan imunisasi sejak lahir. Indikator ini diharapkan dapat menunjukkan kemampuan sistem dalam menjangkau bayi di usia akhir tahun pertama, yang sering kali lebih sulit dijangkau dibanding imunisasi dasar awal. Indikator cakupan imunisasi HPV digunakan sebagai indikator RPJMN dan Indikator kinerja kegiatan untuk memberikan gambaran investasi kesehatan jangka panjang SDM perempuan, transformasi sistem kesehatan dari kuratif ke preventif, dan bentuk perluasan serta pemerataan layanan imunisasi.

Aspek utama dalam pelaksanaan imunisasi adalah vaksin. Dalam hal ini tidak hanya harus memperhatikan ketersediaannya dalam mendukung target imunisasi yang ditentukan, namun juga memperhatikan kualitasnya agar vaksin yang diberikan tetap dalam kondisi poten sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang menerima. Pelayanan imunisasi yang bermutu memerlukan sistem pengelolaan rantai dingin vaksin yang terjaga baik sesuai standar. Penyimpanan dan distribusi vaksin membutuhkan perhatian khusus karena vaksin merupakan sediaan biologis yang rentan terhadap perubahan suhu lingkungan. Vaksin harus ditempatkan di dalam peralatan penyimpan dan distribusi sesuai karakteristiknya yakni sensitif beku atau sensitif panas baik pada saat penyimpanan maupun pendistribusian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Vaksin yang disimpan atau diangkut secara tidak benar tentu berisiko akan kehilangan potensinya. Dalam Program Imunisasi, pengalaman menunjukkan bahwa rantai vaksin yang baik merupakan salah satu elemen penentu. WHO telah merekomendasikan suatu sistem yang digunakan dalam penyimpanan maupun pendistribusian vaksin agar senantiasa dalam kondisi baik yaitu cold chain (rantai dingin). Cold chain merupakan prosedur yang saling berkaitan dan dirancang untuk menjaga vaksin dalam kisaran suhu yang direkomendasikan (pada umumnya di kisaran suhu 2oC s.d. 8oC) dari titik produksi hingga diberikan kepada sasaran di pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pendistribusian logistik imunisasi diantaranya berupa peralatan cold chain. Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan rantai dingin vaksin yang berkualitas maka diperlukan penyediaan peralatan cold chain berupa sarana penyimpan vaksin, alat pembawa vaksin alat mempertahankan suhu dan alat pemantau suhu. Sarana peyimpan vaksin meliputi cold room (2oC s.d. 8oC) freezer room (-25oC s.d -15oC), vaccine refrigerator (2oC s.d. 8oC), dan freezer (-25oC s.d -15oC). Cold room harus tersedia di level pusat dan provinsi, namun dimungkinkan juga tersedia di level kabupaten/kota dengan pertimbangan kebutuhan kapasitas simpan yang besar karena sasaran yang memang besar dan efektifitas distribusi pada daerah terpencil/kepulauan. Freezer room hanya dibutuhkan pada provinsi dengan jumlah sasaran sangat besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Freezer tersedia di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan vaccine refrigerator tersedia di level provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas/fasyankes. Dalam hal sarana penyimpan vaksin ini, dasar pertimbangan dalam pemilihan jenis dan tipe peralatan adalah: level pengelolaan, jumlah sasaran, volume vaksin, sumber energi yang tersedia serta faktor lain seperti kondisi geografis dan karakteristik vaksin yang akan disimpan (sensitif beku atau sensitif panas).

Terkait ketersediaan peralatan penyimpan vaksin, saat ini terdapat 197 unit cold room yang tersebar di 38 provinsi dan 100 kabupaten/kota dimana 174 unit diantaranya dalam kondisi berfungsi baik, 9 unit dalam kondisi rusak,11 unit perlu perbaikan dan 3 unit dalam perbaikan. Untuk freezer room, 3 unit yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat ini sudah rusak dikarenakan faktor usia alat (rerata di atas 30 tahun). Untuk vaccine refrigerator, terdapat sekitar 20.111 unit yang tersebar di 38 dinas kesehatan provinsi, 514 dinas kesehatan kabupaten/kota dan 10.256 puskesmas. Jumlah vaccine refrigerator di dinas kesehatan 38 provinsi sebanyak 231 unit (dengan kondisi: 212 unit berfungsi, 15 unit rusak, 1 unit perlu perbaikan, 3 unit dalam perbaikan), di dinas kesehatan kabupaten/kota sebanyak 3.034 (dengan kondisi: 2.337 unit berfungsi, 256 unit rusak, 221 unit perlu perbaikan, 20 unit dalam perbaikan), dan di puskesmas sebanyak 16.846 unit (dengan kondisi: 14.055 unit berfungsi, 2.448 unit rusak, 221 unit perlu perbaikan, 122 unit dalam perbaikan). Jumlah vaccine freezer di dinas kesehatan 38 provinsi sebanyak 109 unit dengan kondisi: 100 unit berfungsi, 7 unit rusak, dan 2 unit dalam perbaikan, sedangkan di dinas kesehatan kabupaten/kota sebanyak 414 unit dengan kondisi: 347 unit berfungsi, 59 unit rusak, 6 unit perlu perbaikan dan 2 unit dalam perbaikan (sumber data: SMILE, Juni 2025)

Berdasarkan data di atas di ketahui bahwa masih ada 160 puskemas yang tidak memiliki vaccine refrigerator (data Kemenkes 2023: terdapat 10.416 puskesmas di Indonesia)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Beberapa tantangan dan permasalahan utama terkait penurunan cakupan imunisasi antara lain yaitu adanya penolakan orang tua, pembiayaan BOK yang belum optimal, ketersediaan vaksin yang belum tepat waktu dan jumlah, pergantian petugas yang tinggi, dan lain-lain. Tantangan dan permasalahan ini diperkuat oleh hasil studi Nielsen UNICEF yang menyebutkan bahwa hampir 38% orang tua tidak mau imunisasi karena suntikan ganda, jadwal pelayanan imunisasi yang tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sesuai (18%) dan khawatir efek simpang (12%). Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 juga menyebutkan bahwa alasan terbesar anak tidak diimunisasi adalah karena tidak diberikan izin oleh keluarga (47%) dan kekhawatiran terhadap efek simpang (45%). Faktor yang mendukung penolakan orang tua dan kekhawatiran terhadap efek simpang ternyata dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, status pekerjaan dan status ekonomi kepala rumah tangga. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 memberikan gambaran bahwa anak usia 12-23 bulan yang tidak lengkap status imunisasi dan tidak imunisasi berada pada kelompok kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah, pekerjaan tidak tetap dan status ekonomi menengah ke bawah. Dalam studi pembiayaan imunisasi daerah dan implikasinya, menyebutkan bahwa besarnya kesenjangan cakupan imunisasi antar daerah ternyata juga dipengaruhi oleh alokasi pembiayaan BOK per sasaran dan tingkat kemiskinan. Daerah dengan kemiskinan besar akan menghadapi resiko rendahnya cakupan imunisasi.

Tantangan dan hambatan bukan hanya dari sisi demand/permintaan saja, dari sisi penyedia kita juga masih menghadapi permasalahan. Berdasarkan survei Training Needs Assessment (TNA), lebih dari 70% tenaga imunisasi belum mendapatkan pelatihan imunisasi dan hanya 14% petugas yang telah mengikuti pelatihan surveilans PD3I dalam tiga tahun terakhir. Supervisi suportif secara berjenjang belum berjalan secara optimal, meskipun alat penilaian seperti checklist telah tersedia. Selain itu, kita juga menghadapi keterlambatan dalam pengadaan dan distribusi vaksin, terutama di tingkat layanan. Berdasarkan tarikan data SMILE, pernah terjadi kekosongan vaksin secara nasional untuk beberapa antigen. Hal ini terjadi akibat keterbatasan pasokan bahan baku antigen tertentu yang masih diimpor. Ketidakcukupan persediaan vaksin yang pernah terjadi antara lain untuk vaksin IPV, OPV, BCG, DPT-Hb-HiB, dan MR.

Sejak Januari 2023, Kemenkes membuat inovasi pencatatan dan pelaporan berbasis digital. Namun, belum semua petugas dan daerah melakukan input data secara tepat waktu dan akurat, masih ada perbedaan cakupan 15-30% antara laporan digital dan manual. Interoperabilitas data digital yaitu antara ASIK dan SMILE dalam platform SATUSEHAT dari semua fasilitas kesehatan termasuk swasta, masih menghadapi berbagai kendala. Hingga menjelang akhir 2024, kepatuhan petugas dan pemanfaatan data digital belum dapat berjalan dengan baik untuk informasi yang valid dan real time.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi Kementerian Kesehatan adalah : Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Searah dengan visi Kemenkes maka Visi Ditjen P2 adalah "*Masyarakat Bebas Penyakit Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045*". Sebagai upaya dukungan terhadap visi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Direktorat Imunisasi menetapkan visi "**Masyarakat Indonesia terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) untuk mendukung generasi yang tangguh, hebat dan berdaya saing"**

2.2. Misi

Kementerian Kesehatan memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. Mewujudkan kementerian kesehatan yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mendukung misi Kementerian Kesehatan tersebut, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit memiliki misi sebagai berikut :

1. Menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular melalui penguatan intervensi promotif, preventif, kuratif , rehabilitative dan/atau paliatif berbasis siklus hidup.
2. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit di masyarakat
4. Memperkuat imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
5. Meningkatkan kualitas sistem ketahanan kesehatan melalui Upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian faktor risiko lingkungan
6. Meningkatkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan STBM
7. Meningkatkan sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di wilayah dan pintu masuk negara
8. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui Perencanaan berbasis data, Transparansi anggaran dan pelaporan program.
9. Monitoring dan evaluasi berkala dan objektif
10. Meningkatkan tata kelola program penanggulangan penyakit melalui perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, evaluasi berkala, serta penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi multisektoktor

Direktorat Imunisasi sebagai unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, menetapkan visi "**Masyarakat Indonesia terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) untuk mendukung generasi yang tangguh, hebat dan berdaya saing'** dengan misi sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Memperkuat program imunisasi sesuai siklus hidup
2. Mempertahankan status Indonesia bebas Polio dan mendukung tercapainya eradikasi Polio secara global
3. Memperkuat upaya mencapai status eliminasi Campak Rubella
4. Memperkuat pelaksanaan surveilans PD3I dan KIPI

2.3. Tujuan

Tujuan Kementerian Kesehatan adalah :

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup dengan Indikator : Usia harapan Hidup Sehat/*Healty Adjusted Life Expectancy* (HALE)
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau, dengan Indikator : Cakupan layanan Kesehatan Esensial /*Universal Health Coverage* (UHC) *Service Coverage Index*
3. Sistem Ketahanan yang tangguh dan responsive, dengan Indikator ; *International Health Regulation* (IJR) score
4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan dengan Indikator: Rasio belanja Kesehatan pee kapita terhadap usia
5. Teknologi Kesehatan yang maju dengan Indikator: Persentase populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien dengan Indikator Nilai *Good Public Governance* (GPG) Kementerian Kesehatan

Searah dengan tujuan Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Masyarakat bebas penyakit menular dan tidak menular
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat
3. Masyarakat mendapat layanan imunisasi lengkap sesuai siklus hidup
4. Masyarakat hidup dalam Lingkungan sehat
5. Sistem yang mampu mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman kesehatan secara efektif dan cepat
6. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit yang agile, efektif dan efisien

Selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Direktorat Imunisasi, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 – 2029 adalah: "***Memastikan Semua Sasaran Imunisasi Mendapat Imunisasi Lengkap***"

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif
2. Meningkatnya literasi kesehatan maasyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
4. Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan
5. Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah
6. Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis
7. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

Sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan **Sasaran Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit** untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Meningkatnya proporsi kabupaten/kota yang menyelenggarakan skrining penyakit tidak menular prioritas
2. Meningkatnya pengendalian penyakit dan faktor risiko penyakit tidak menular
3. Meningkatnya tatalaksana penyakit kanker
4. Menurunnya proporsi perokok usia 10-21 tahun
5. Meningkatnya produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi batas maksimum kandungan Gula Garam Lemak (GGL)
6. Meningkatnya Skrining kolesterol pada Puskemas
7. Menurunnya insiden penyakit menular
8. Meningkatnya eliminasi penyakit menular
9. Menurunnya kematian akibat penyakit menular
10. Menurunnya proporsi obesitas di kabupaten/kota
11. Tercapainya imunisasi lengkap pada populasi
12. Menurunnya kejadian penyakit menular sensitif iklim
13. Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
14. Meningkatnya kabupaten/kota yang mendeteksi, merespon dan mengendalikan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
15. Meningkatnya desa/kelurahan yang menerapkan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkelanjutan
16. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di kabupaten/kota
17. Menurunnya jumlah KLB Keracunan Pangan
18. Meningkatnya kabupaten/kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan
19. Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan

Sasaran Strategis Kegiatan

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan Direktorat Imunisasi antara lain:

1. Meningkatnya cakupan imunisasi pada kelompok sasaran
2. Surveilans PD3I yang adekuat

2.5. Manajemen Resiko

Manajemen risiko diperlukan untuk menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran program, dalam pelaksanaan nya manajemen risiko harus diterapkan mulai dari perencanaan, manajemen kinerja, dan penganggaran guna mendukung terwujudnya pembangunan bidang kesehatan serta memastikan bahwa tujuan kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya sasaran kegiatan di lingkungan Direktorat Imunisasi, sebagaimana dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Risk Register Direktorat Imunisasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
Sasaran kegiatan: Meningkatnya cakupan imunisasi pada kelompok sasaran			
1. Cakupan Imunisasi MR 1 Pada Bayi	1. Penolakan masyarakat di beberapa daerah terkait imunisasi	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan dalam edukasi imunisasi ke masyarakat; 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKKBN, dan Mitra Pembangunan dalam menyusun kebijakan bersama	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		dan amplifikasi informasi edukasi imunisasi ke Masyarakat; 3. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan dan Kementerian/Lembaga untuk penguatan program imunisasi; 4. Bekerjasama dengan Direktorat Kesehatan Keluarga dan Politeknik Kesehatan dalam edukasi imunisasi kepada peserta didik dan masyarakat; 5. Bersama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan melakukan analisa, counter hoax dan amplifikas informasi edukasi imunisasi; 6. Bersama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas serta Biro komunikasi dan Pelayanan Publik dalam penyampaian informasi program imunisasi di website Kementerian Kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum; 7. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Direktorat Promosi Kesehatan untuk melakukan Pelatihan KAP kepada petugas kesehatan; 8. Meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, media informasi, tokoh masyarakat, public figure, penyelenggaraan kegiatan pada event mass gathering, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat imunisasi, vaksin aman, dan bahaya penyakit PD3I.	
	2. Cakupan imunisasi tidak terinput ke ASIK dengan rutin / *real time*	1. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk segera memperbaiki sistem Aplikasi ASIK; 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/workshop/sosialisasi; 3. Mendorong penyediaan Helpdesk atau tenaga teknis pendamping ASIK; 4. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk pencatatan offline sebagai backup data di ASIK; 5. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk melakukan interoperabilitas Rekam Medik Elektronik faskes swasta ke SATUSEHAT.	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak
	3. Pengelola program imunisasi belum semuanya terlatih	1. Peningkatan kapasitas pengelola program imunisasi melalui pelatihan/ workshop/ webinar/sosialisasi; 2. Bimbingan teknis bagi provinsi, kab/kota, dan Puskesmas dalam pengelolaan program imunisasi; 3. Melakukan pemetaan pengelola program imunisasi yang telah terlatih; 4. Memastikan penyediaan menu pelatihan tersedia pada BOK non fisik;	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak
	4. Ketersediaan vaksin tidak sesuai kebutuhan	1. Melakukan analisa dalam perencanaan vaksin; 2. Melakukan pemantauan, analisa, dan koordinasi ketersediaan vaksin di semua entitas; 3. Berkoordinasi untuk penyusunan Modul pelatihan secara online pada aplikasi SMILE; 4. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk kegiatan stock opname rutin; 5. Mendorong Dit. Penyanfar untuk memasukkan dalam kontrak perjanjian pengadaan vaksin agar sesuai kebutuhan (tepat waktu dan tepat jumlah); 6. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk melakukan proses pengadaan vaksin dengan platform/spesifikasi yang sama untuk setiap jenis antigennya; 7. Mendorong Dit. Penyanfar dan Dinkes Provinsi untuk mengupayakan re-alokasi vaksin yang ada antar provinsi agar layanan imunisasi tetap dapat berjalan.	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak
2. Cakupan Imunisasi Antigen Baru	1. Penolakan masyarakat di	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi	Tim Kerja Imunisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	beberapa daerah terkait imunisasi	masyarakat, dan mitra pembangunan dalam edukasi imunisasi ke masyarakat; 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKKBN, dan Mitra Pembangunan dalam menyusun kebijakan bersama dan amplifikasi informasi edukasi imunisasi ke Masyarakat; 3. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan dan Kementerian/Lembaga untuk penguatan program imunisasi; 4. Bekerjasama dengan Direktorat Kesehatan Keluarga dan Politeknik Kesehatan dalam edukasi imunisasi kepada peserta didik dan masyarakat; 5. Bersama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan melakukan analisa, counter hoax dan amplifikas informasi edukasi imunisasi; 6. Bersama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas serta Biro komunikasi dan Pelayanan Publik dalam penyampaian informasi program imunisasi di website Kementerian Kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum; 7. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Direktorat Promosi Kesehatan untuk melakukan Pelatihan KAP kepada petugas kesehatan 8. Meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, media informasi, tokoh masyarakat, public figure, penyelenggaraan kegiatan pada event mass gathering, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat imunisasi, vaksin aman, dan bahaya penyakit PD3I	Dewasa, Antigen Baru, dan Tambahan
	2. Ketersediaan vaksin tidak sesuai kebutuhan	1. Melakukan analisa dalam perencanaan vaksin; 2. Melakukan pemantauan, analisa, dan koordinasi ketersediaan vaksin di semua entitas; 3. Berkoordinasi untuk penyusunan Modul pelatihan secara online pada aplikasi SMILE; 4. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk kegiatan stock opname rutin; 5. Mendorong Dit. Penyanfar untuk memasukkan dalam kontrak perjanjian pengadaan vaksin agar sesuai kebutuhan (tepat waktu dan tepat jumlah); 6. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk melakukan proses pengadaan vaksin dengan platform/spesifikasi yang sama untuk setiap jenis antigennya; 7. Mendorong Dit. Penyanfar dan Dinkes Provinsi untuk mengupayakan re-alokasi vaksin yang ada antar provinsi agar layanan imunisasi tetap dapat berjalan.	Tim Kerja Imunisasi Dewasa, Antigen Baru, dan Tambahan
	3. Pengelola program imunisasi belum semuanya terlatih	1. Peningkatan kapasitas pengelola program imunisasi melalui pelatihan/ workshop/ webinar/sosialisasi; 2. Bimbingan teknis bagi provinsi, kab/kota, dan Puskesmas dalam pengelolaan program imunisasi; 3. Melakukan pemetaan pengelola program imunisasi yang telah terlatih; 4. Memastikan penyediaan menu pelatihan tersedia pada BOK non fisik;	Tim Kerja Imunisasi Dewasa, Antigen Baru, dan Tambahan
	4. Cakupan imunisasi tidak terinput ke ASIK dengan rutin / real time	1. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk segera memperbaiki sistem Aplikasi ASIK; 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/workshop/sosialisasi; 3. Mendorong penyediaan Helpdesk atau tenaga teknis pendamping ASIK; 4. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk pencatatan offline	Tim Kerja Imunisasi Dewasa, Antigen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		sebagai backup data di ASIK; 5. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk melakukan interoperabilitas Rekam Medik Elektronik faskes swasta ke SATUSEHAT.	Baru, dan Tambahan
3. Cakupan Imunisasi HPV	1. Penolakan orang tua/wali anak dan pihak sekolah untuk mendapatkan imunisasi HPV	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan dalam edukasi imunisasi pada anak usia sekolah dan wali murid; 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, dan Mitra Pembangunan dalam menyusun kebijakan bersama dan amplifikasi informasi edukasi imunisasi pada anak usia sekolah; 3. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan dan Kementerian/Lembaga untuk penguatan program imunisasi pada anak usia sekolah; 4. Bersama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan melakukan analisa, counter hoax dan amplifikas informasi edukasi imunisasi pada anak usia sekolah; 5. Bersama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas serta Biro komunikasi dan Pelayanan Publik dalam penyampaian informasi program imunisasi di website Kementerian Kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum; 6. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Direktorat Promosi Kesehatan untuk melakukan Pelatihan KAP kepada petugas kesehatan dan kader; 7. Meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, media informasi, tokoh masyarakat, public figure, penyelenggaraan kegiatan pada event mass gathering, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat imunisasi, vaksin aman, dan bahaya penyakit PD3I.	Tim Kerja Imunisasi Dewasa, Antigen Baru, dan Tambahan
	2. Cakupan imunisasi tidak terinput ke ASIK dengan rutin / real time	1. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk segera memperbaiki sistem Aplikasi ASIK; 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/workshop/sosialisasi; 3. Mendorong penyediaan Helpdesk atau tenaga teknis pendamping ASIK; 4. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk pencatatan offline sebagai backup data di ASIK; 5. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk melakukan interoperabilitas Rekam Medik Elektronik faskes swasta ke SATUSEHAT.	Tim Kerja Imunisasi Dewasa, Antigen Baru, dan Tambahan
	3. Ketersediaan vaksin tidak sesuai kebutuhan	1. Melakukan analisa dalam perencanaan vaksin; 2. Melakukan pemantauan, analisa, dan koordinasi ketersediaan vaksin di semua entitas; 3. Berkoordinasi untuk penyusunan Modul pelatihan secara online pada aplikasi SMILE; 4. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk kegiatan stock opname rutin; 5. Mendorong Dit. Penyanfar untuk memasukkan dalam kontrak perjanjian pengadaan vaksin agar sesuai kebutuhan (tepat waktu dan tepat jumlah); 6. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk melakukan proses pengadaan vaksin dengan platform/spesifikasi yang sama untuk setiap jenis antigennya; 7. Mendorong Dit. Penyanfar dan Dinkes Provinsi untuk mengupayakan re-alokasi vaksin yang ada antar	Tim Kerja Imunisasi Dewasa, Antigen Baru, dan Tambahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		provinsi agar layanan imunisasi tetap dapat berjalan.	
4. Cakupan Imunisasi Lengkap pada Baduta	1. Tingginya angka *Zero Dose* dan *missed children*	1. Bekerjasama dengan Rokom dan Kominfo dalam counter hoax imunisasi; 2. Berkoordinasi dengan Rokom dalam amplifikasi berita pentingnya imunisasi dan bahaya PD3I; 3. Bekerjasama dengan CSO/poltekkes/KL lainnya dalam pelacakan sasaran dan imunisasi kejar; 4. Bekerjasama dengan Promosi Kesehatan dan mintra pembangunan dalam melakukan orientasi KAP (Komunikasi Antar Personal) bagi petugas imunisasi secara online.	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak
	2. Cakupan imunisasi tidak terinput ke ASIK dengan rutin / real time	1. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk segera memperbaiki sistem Aplikasi ASIK; 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/workshop/sosialisasi; 3. Mendorong penyediaan Helpdesk atau tenaga teknis pendamping ASIK; 4. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk pencatatan offline sebagai backup data di ASIK; 5. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk melakukan interoperabilitas Rekam Medik Elektronik faskes swasta ke SATUSEHAT.	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak
	3. Rotasi petugas yang sudah dilatih tinggi	Bersama Kemendagri melakukan Advokasi Pimpinan Daerah agar tidak terlalu sering melakukan rotasi Petugas Imunisasi	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak
	4. Penolakan masyarakat di beberapa daerah terkait imunisasi	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan dalam edukasi imunisasi ke masyarakat; 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKKBN, dan Mitra Pembangunan dalam menyusun kebijakan bersama dan amplifikasi informasi edukasi imunisasi ke Masyarakat; 3. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan dan Kementerian/Lembaga untuk penguatan program imunisasi; 4. Bekerjasama dengan Direktorat Kesehatan Keluarga dan Politeknik Kesehatan dalam edukasi imunisasi kepada peserta didik dan masyarakat; 5. Bersama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan melakukan analisa, counter hoax dan amplifikas informasi edukasi imunisasi; 6. Bersama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas serta Biro komunikasi dan Pelayanan Publik dalam penyampaian informasi program imunisasi di website Kementerian Kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum; 7. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Direktorat Promosi Kesehatan untuk melakukan Pelatihan KAP kepada petugas kesehatan; 8. Meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, media informasi, tokoh masyarakat, public figure, penyelenggaraan kegiatan pada event mass gathering, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat imunisasi, vaksin aman, dan bahaya penyakit PD3I	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak
	5. Ketersediaan	1. Melakukan analisa dalam perencanaan vaksin;	Tim Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	vaksin tidak sesuai kebutuhan	2. Melakukan pemantauan, analisa, dan koordinasi ketersediaan vaksin di semua entitas; 3. Berkoordinasi untuk penyusunan Modul pelatihan secara online pada aplikasi SMILE; 4. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk kegiatan stock opname rutin; 5. Mendorong Dit. Penyanfar untuk memasukkan dalam kontrak perjanjian pengadaan vaksin agar sesuai kebutuhan (tepat waktu dan tepat jumlah); 6. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk melakukan proses pengadaan vaksin dengan platform/spesifikasi yang sama untuk setiap jenis antigennya; 7. Mendorong Dit. Penyanfar dan Dinkes Provinsi untuk mengupayakan re-alokasi vaksin yang ada antar provinsi agar layanan imunisasi tetap dapat berjalan.	Imunisasi Bayi dan Anak
5. Cakupan Imunisasi di Usia Sekolah Dasar	1. Penolakan orang tua/wali anak dan pihak sekolah untuk mendapatkan imunisasi	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan dalam edukasi imunisasi pada anak usia sekolah dan wali murid; 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, dan Mitra Pembangunan dalam menyusun kebijakan bersama dan amplifikasi informasi edukasi imunisasi pada anak usia sekolah 3. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan dan Kementerian/Lembaga untuk penguatan program imunisasi pada anak usia sekolah; 4. Bersama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan melakukan analisa, counter hoax dan amplifikas informasi edukasi imunisasi pada anak usia sekolah; 5. Bersama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas serta Biro komunikasi dan Pelayanan Publik dalam penyampaian informasi program imunisasi di website Kementerian Kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum; 6. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Direktorat Promosi Kesehatan untuk melakukan Pelatihan KAP kepada petugas kesehatan dan kader; 7. Meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, media informasi, tokoh masyarakat, public figure, penyelenggaraan kegiatan pada event mass gathering, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat imunisasi, vaksin aman, dan bahaya penyakit PD3I.	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak
	2. Cakupan imunisasi tidak terinput ke ASIK dengan rutin / *real time*	1. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk segera memperbaiki sistem Aplikasi ASIK; 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/workshop/sosialisasi; 3. Mendorong penyediaan Helpdesk atau tenaga teknis pendamping ASIK; 4. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk pencatatan offline sebagai backup data di ASIK; 5. Mendorong Pusdatin/TTDK untuk melakukan interoperabilitas Rekam Medik Elektronik faskes swasta ke SATUSEHAT.	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak
	3. Ketersediaan vaksin tidak sesuai kebutuhan	1. Melakukan analisa dalam perencanaan vaksin; 2. Melakukan pemantauan, analisa, dan koordinasi ketersediaan vaksin di semua entitas; 3. Berkoordinasi untuk penyusunan Modul pelatihan secara online pada aplikasi SMILE; 4. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk kegiatan	Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		stock opname rutin; 5. Mendorong Dit. Penyanfar untuk memasukkan dalam kontrak perjanjian pengadaan vaksin agar sesuai kebutuhan (tepat waktu dan tepat jumlah); 6. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk melakukan proses pengadaan vaksin dengan platform/spesifikasi yang sama untuk setiap jenis antigennya; 7. Mendorong Dit. Penyanfar dan Dinkes Provinsi untuk mengupayakan re-alokasi vaksin yang ada antar provinsi agar layanan imunisasi tetap dapat berjalan.	
6. Cakupan Status Imunisasi T2+ pada Wanita Usia Subur (Wus)	1. Kemampuan petugas dalam melakukan Screening status TT pada WUS masih kurang	1. Berkoordinasi dengan Dit. KIA untuk memasukan laporan capaian status TT pada ibu hamil; 2. Menyusun modul pelatihan Online (MOOC); 3. Melaksanakan desk review secara rutin sampai dengan tingkat puskesmas;	Tim Kerja Imunisasi Dewasa, Antigen Baru, dan Tambahan
	2. Pengelola program imunisasi belum semuanya terlatih	1. Peningkatan kapasitas pengelola program imunisasi melalui pelatihan/workshop/sosialisasi; 2. Melakukan pemetaan pengelola program imunisasi yang telah terlatih; 3. Memastikan penyediaan menu pelatihan tersedia pada BOK non fisik.	Tim Kerja Imunisasi Dewasa, Antigen Baru, dan Tambahan
	3. Penolakan masyarakat di beberapa daerah terkait imunisasi	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan dalam edukasi imunisasi ke masyarakat; 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKKBN, dan Mitra Pembangunan dalam menyusun kebijakan bersama dan amplifikasi informasi edukasi imunisasi ke Masyarakat; 3. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan dan Kementerian/Lembaga untuk penguatan program imunisasi; 4. Bekerjasama dengan Direktorat Kesehatan Keluarga dan Politeknik Kesehatan dalam edukasi imunisasi kepada peserta didik dan masyarakat; 5. Bersama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan melakukan analisa, counter hoax dan amplifikas informasi edukasi imunisasi; 6. Bersama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas serta Biro komunikasi dan Pelayanan Publik dalam penyampaian informasi program imunisasi di website Kementerian Kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum; 7. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Direktorat Promosi Kesehatan untuk melakukan Pelatihan KAP kepada petugas kesehatan; 8. Meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, media informasi, tokoh masyarakat, public figure, penyelenggaraan kegiatan pada event mass gathering, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat imunisasi, vaksin aman, dan bahaya penyakit PD3I.	Tim Kerja Imunisasi Dewasa, Antigen Baru, dan Tambahan
	4. Ketersediaan vaksin tidak sesuai	1. Melakukan analisa dalam perencanaan vaksin; 2. Melakukan pemantauan, analisa, dan koordinasi ketersediaan vaksin di semua entitas;	Tim Kerja Imunisasi Dewasa,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	kebutuhan	3. Berkoordinasi untuk penyusunan Modul pelatihan secara online pada aplikasi SMILE; 4. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk kegiatan stock opname rutin; 5. Mendorong Dit. Penyanfar untuk memasukkan dalam kontrak perjanjian pengadaan vaksin agar sesuai kebutuhan (tepat waktu dan tepat jumlah); 6. Berkoordinasi dengan Dit. Penyanfar untuk melakukan proses pengadaan vaksin dengan platform/spesifikasi yang sama untuk setiap jenis antigennya; 7. Mendorong Dit. Penyanfar dan Dinkes Provinsi untuk mengupayakan re-alokasi vaksin yang ada antar provinsi agar layanan imunisasi tetap dapat berjalan.	Antigen Baru, dan Tambahan
Sasaran kegiatan: Surveilans PD3I yang adekuat			
Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I	1. Terbatasnya biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen PD3I	1. Penyusunan draft RPMK terkait tarif PNBP 0 Rupiah atau kebijakan khusus terkait nol rupiah; 2. Berkoordinasi dengan unit pengampu pengadaan farmasi dan alat kesehatan untuk mengawal reagen; 3. Identifikasi Daerah yang mampu melakukan pembiayaan pemeriksaan PD3I dan melakukan advokasi pembiayaan pemeriksaan PD3I;	Tim Kerja Surveilans PD3I dan KIPI
	2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan petugas dalam manajemen spesimen PD3I	1. Bimbingan teknis bagi provinsi, kab/kota, dan Puskesmas dalam manajemen spesimen PD3I; 2. Pelatihan/Webinar/Workshop/OJT bagi petugas surveilans	Tim Kerja Surveilans PD3I dan KIPI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan

Sesuai arah kebijakan Kemenkes, maka dirumuskan arah kebijakan dan stratetgi Ditjen P2 untuk mendukung arah kebijakan strategi nasional dalam mencapai sasaran program lingkup Ditjen P2. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan dengan tetap menjalankan arah kebijakan dan strategi nasional.

Selaras dengan Renstra Kementerian Kesehatan, arah kebijakan Ditjen Penanggulangan Penyakit selama lima tahun ke depan adalah "*Terselenggaranya penanggulangan penyakit secara merata, terpadu, dan berkesinambungan di setiap wilayah dan pintu masuk melalui implementasi transformasi Kesehatan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan penanggulangan penyakit*"

Penanggulangan penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan, disabilitas dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dengan skrining dan deteksi dini faktor risiko , pemberian imunisasi , surveilans penyakit dan faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan hidup sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan

Direktorat Imunisasi menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memastikan setiap individu mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai dengan usianya
2. Memastikan setiap kabupaten/kota mencapai target kinerja surveilans PD3I

3.2. Strategi

Untuk mendukung transformasi layanan primer terkait imunisasi, dirumuskan strategi umum pelaksanaan imunisasi dengan menjamin ketersediaan SDM, vaksin dan logistik imunisasi lainnya; meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi; memastikan layanan imunisasi menjangkau semua masyarakat; memastikan pelaksanaan surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebagai upaya pencegahan terjadinya KLB PD3I; Melaksanakan perbaikan tata kelola program imunisasi untuk menjamin terlaksananya sistem monitoring terintegrasi program imunisasi kedalam satu sehat, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imunisasi memperhatikan sasaran dan indikator dalam Renstra, selain strategi yang bersifat umum, juga dirumuskan strategi khusus sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM imunisasi melalui berbagai metode pelatihan dan pemanfaatan tenaga kesehatan lain untuk mendukung program imunisasi
2. Memastikan pengadaan ketersediaan, distribusi vaksin dan logistik lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu melalui :
   a. Perencanaan kebutuhan vaksin sesuai dengan sasaran dengan melibatkan unit-unit terkait
   b. Koordinasi dengan unit teknis terkait untuk memastikan ketersediaan vaksin dan logistik penunjang program imunisasi sesuai kebutuhan (jenis, jumlah, dan tepat waktu)
3. Meningkatkan kolaborasi layanan imunisasi di fasyankes swasta dan fasyankes lainnya
4. Mengadakan peralatan rantai dingin vaksin sesuai kebutuhan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SATUSEHAT Logistik di setiap tingkatan.
6. Memasukkan skrining status imunisasi dalam Program CKG
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan konten imunisasi di kanal kanal media komunikasi lintas program dan lintas Kementerian/Lembaga dan jejaringnya serta media sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Melibatkan kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan influencer dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya imunisasi
9. Melibatkan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, akademisi, dan mitra pembangunan dalam mendorong anggotanya sebagai penggiat imunisasi
10. Melibatkan jurnalis dalam komunikasi risiko imunisasi
11. Melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat(PWS) dan tindak lanjut setiap bulan, melalui penguatan imunisasi rutin dan kejar.
12. Implementasi Kegiatan Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI)
13. Melaksanakan imunisasi tambahan di daerah berisiko tinggi untuk mencegah KLB dan untuk menanggulangi KLB
14. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SATUSEHAT IndonesiaKu untuk pencatatan dan pelaporan program imunisasi
15. Melaksanakan layanan berbasis sustainable outreach services (SOS) di daerah sulit, terpencil, dan risiko tinggi
16. Memperkuat kolaborasi antar program, sektor, dan mitra pembangunan, termasuk dengan komunitas yang berakar pada budaya lokal
17. Memperkuat pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imunisasi dan surveilans PD3I
18. Membentuk tim Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS) di rumah sakit pemerintah dan swasta
19. Melakukan koordinasi rutin antara dinas kesehatan dengan tim SARS
20. Memperkuat jejaring laboratorium rujukan surveilans PD3I
21. Meningkatkan kapasitas SDM untuk pelaksanaan surveilans PD3I
22. Mengoptimalkan peran aktif Komnas KIPI
23. Membentuk dan mengoptimalkan peran aktif Komda KIPI
24. Mengoptimalkan peran vocal point pada dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota
25. Memastikan pembiayaan daerah untuk tatalaksana KIPI

3.3. Kerangka Regulasi

Sebagaimana UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pengelolaan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sektor kesehatan bertujuan untuk:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan program pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan kesehatan; dan
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Saat ini sudah terdapat beberapa regulasi dalam upaya pengelolaan imunisasi, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Permenkes No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12/2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/449/2020 tentang Perluasan Program Demonstrasi Pemberian Imunisasi HPV Tahun 2020 – 2024 yang diperbaharui dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HK.01.07/MENKES/6779/2021 tentang Program Introduksi Imunisasi Human Papilloma Virus Vaccine (HPV) Tahun 2022 – 2024

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/ 6780/ 2021 tentang Pemberian Imunisasi Pneumokokus Konyugasi yang diubah menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/ 779/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/ 6780/ 2021 tentang Pemberian Imunisasi Pneumokokus Konyugasi
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/ 1139/ 2022 tentang Pemberian Imunisasi Rotavirus
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1453/2022 tentang Program Introduksi Imunisasi Inactivated Poliovirus Vaccine Dosis Kedua (IPV2)
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/35/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/1098/2024 tentang Jenis dan Jadwal Imunisasi Program
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor HK0.08/MENKES/1325/2022 Tentang Penyelengaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik

Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas, efektif dan efisien, serta tepat sasaran sesuai kebutuhan, dibutuhkan upaya penguatan regulasi baik terhadap regulasi yang telah ada (existing regulation) maupun regulasi yang akan dibentuk (future regulation). Berdasarkan kebutuhan dalam rangka mengoptimalkan capaian sasaran dalam Rencana Aksi Kegiatan ini, maka kerangka regulasi yang dibutuhkan/perlu dibentuk yaitu sebagaimana berikut:

1. KMK turunan dari Permenkes Nomor 17 tahun 2023
2. Revisi Buku Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi Puskesmas Tahun 2023
3. Revisi KMK Imunisasi HPV
4. Revisi KMK jenis dan jadwal imunisasi
5. Revisi Petunjuk Teknis Program Imunisasi HPV dalam BIAS
6. Revisi Petunjuk Teknis Surveilans AFP dan Surveilans Pertusis
7. Petunjuk Teknis Surveilans Campak - Rubella
8. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surveilans PD3I di Rumah Sakit (Kepmenkes)
9. Rancangan Permenkes tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian kesehatan

3.4. Kerangka Kelembagaan

Selaras dengan kerangka kelembagaan Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Imunisasi yang disusun berpedoman pada Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029, diperlukan kerangka kelembagaan yang efektif, adaptif, dan kolaboratif. Kerangka kelembagaan dalam hal ini merupakan perangkat struktur organisasi dan ketatalaksanaan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Imunisasi yang disusun selaras dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Kementerian Kesehatan.

Penyusunan kerangka kelembagaan Direktorat Imunisasi disusun berdasarkan struktur organisasi, tugas dan fungsi Direktorat Imunisasi yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Dalam prosesnya Direktorat Imunisasi melakukan beberapa tahapan untuk memperkuat kelembagaan Direktorat Imunisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tahapan tersebut antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan Kemenkes
2. Mengidentifikasi kebutuhan perluasan atau penyederhaaan tugas dan fungsi organisasi Direktorat Imunisasi
3. Adaptasi terhadap perubahan pola kerja organisasi yang lebih fleksibel dengan tetap mengedapankan efektifitas efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
4. Memperkuat hubungan kerja Direktorat Imunisasi dengan berbagai lembaga/kementerian/lintas sektor terkait untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Imunisasi
5. Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan untuk memperkuat pelaksanaan tugas fungsi Direktorat Imunisasi.
6. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pengembangan kompetensi di bidang teknis, manajerial maupun sosiokultural
7. Transformasi internal melalui internalisasi budaya kerja Kemenkes (eksekusi efektif, cara kerja baru, pelayanan unggul)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Kinerja Kegiatan pada Direktorat Imunisasi ditetapkan selaras dengan target Ditjen Penanggulangan Penyakit untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Kesehatan. Kinerja Kegiatan Direktorat Imunisasi terbagi dalam kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Pelayanan Kesehatan Primer. Khusus Program pencegahan dan Pengendalian Penyakit, program ini hanya berlaku di tahun 2025 dan tidak berlanjut di tahun berikutnya mengingat mulai tahun 2026 sampai dengan 2029 Kemenkes sudah melaksanakan program baru sesuai transformasi kesehatan. Target dan indikator Kinerja pada tiap Program tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Target dan indikator Kinerja Direktorat Imunisasi tahun 2025-2029

Program	Sasaran	Indikator	Target					Satuan	Sasaran Program yang didukung
			2025	2026	2027	2028	2029		
DO-Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya cakupan imunisasi pada kelompok sasaran	Cakupan imunisasi MR 1 pada bayi	85					persen	Tercapainya imunisasi lengkap pada populasi
		Cakupan imunisasi antigen baru	65					persen	
		Cakupan imunisasi HPV	90					persen	
		Cakupan imunisasi lengkap pada baduta	70					persen	
		Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	88					persen	
		Cakupan status imunisasi T2+ pada Wanita Usia	65					persen	
	Surveilans PD3I yang adekuat	Kabupaten/kota yang mencapai target kinerja surveilans PD3I	86					persen	
DX-Program Pelayanan Kesehatan Primer	Meningkatnya cakupan imunisasi pada kelompok sasaran	Cakupan imunisasi MR 1 pada bayi		88	91	93	95	persen	Tercapainya imunisasi lengkap pada populasi
		Cakupan imunisasi antigen baru		71	77	84	90	persen	
		Cakupan imunisasi HPV		90	90	90	90	persen	
		Cakupan imunisasi lengkap pada baduta		75	80	85	90	persen	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar		90	92	94	95	persen	
		Cakupan status imunisasi T2+ pada Wanita Usia		71	77	84	90	persen	
	Surveilans PD3I yang adekuat	Kabupaten/kota yang mencapai target kinerja surveilans PD3I		87	88	89	90	persen	

Berikut ini adalah rumusan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Imunisasi Tahun 2025– 2029:

1. Cakupan imunisasi MR 1 pada bayi

Imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Bayi merupakan salah satu kelompok rentan yang berisiko tinggi untuk tertular penyakit. Sebelum berusia satu tahun seorang anak harus mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap sebagai bentuk perlindungan dirinya terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Untuk mengukur nilai perlindungan terhadap PD3I yang ada di Indonesia pada kelompok bayi usia 0-11 bulan, selain cakupan Imunisasi bayi lengkap, juga digunakan indikator cakupan bayi (0-11 bulan) yang mendapat imunisasi MR1 sebagai pembanding atau bahan pertimbangan. Campak dan rubella / MR (measles rubella) dosis pertama merupakan antigen terakhir yang diberikan pada usia bayi (0-11 bulan), diharapkan bayi yang sudah diberikan MR juga sudah diberikan rangkaian Imunisasi yang lain pada usia bayi. Indikator ini untuk memastikan bahwa semua antigen Imunisasi sudah diberikan pada usia bayi. Dengan tercapainya target Imunisasi bayi yang mendapat MR1 diharapkan bahwa capaian Imunisasi bayi lengkapnya juga akan meningkat.

Berdasarkan laporan profil kesehatan Indonesia tahun 2022, penyebab kematian post neonatal di tahun 2022 adalah pneumonia (15,3%), kelainan kongenital (7,1%), diare (6,6%), dan lain-lain termasuk PD3I (62,2%). Sementara itu *Case Fatality Rate* (CFR) untuk Difteri (9%) dan Tetanus Neonatorum (57%). Hasil analisa situasi program imunisasi rutin dalam 5 tahun terakhir juga menunjukkan masih adanya disparitas cakupan imunisasi di tingkat provinsi, kabupaten dan bahkan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, di mana jumlah anak-anak yang belum/tidak lengkap status imunisasinya masih banyak yaitu sebesar 1,6 juta anak. Indikator Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) diperlukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan program imunisasi agar berdampak pada penurunan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

Definisi operasional indikator cakupan imunisasi MR 1 pada bayi ini adalah persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi MR 1 di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dengan cara perhitungan adalah jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi MR 1 di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan target bayi usia 0-11 bulan dikali 100%

$$\text{Cakupan Imunisasi MR1 pada bayi} = \frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendpatkan imunisasi MR 1 di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Bayi Surviving Infant (0-11 bulan)}} \times 100\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Cakupan imunisasi antigen baru

Berdasarkan hasil kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (KIN) atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) beban penyakit akibat PD3I semakin bertambah, diantaranya untuk penyakit kanker serviks, pneumonia, penyakit campak dan rubela, dan penyakit diare. Insiden untuk penyakit-penyakit tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, KIN merekomendasikan untuk melakukan pengenalan antigen imunisasi baru antara lain Imunisasi PCV, Imunisasi HPV, Imunisasi Rotavirus, dan Imunisasi IPV2. Imunisasi PCV diberikan dalam upaya pencegahan penyakit pneumonia dan telah dilaksanakan di kab/kota terpilih sebagai program demonstrasi sejak tahun 2017 dan selanjutnya dimasukkan ke dalam imunisasi program nasional pada tahun 2022. Imunisasi HPV diperlukan dalam upaya pencegahan penyakit kanker serviks. Imunisasi Rotavirus diperlukan dalam upaya pencegahan penyakit diare, sedangkan imunisasi IPV 2 diperlukan dalam upaya pencegahan penyakit polio. Imunisasi HPV, Rotavirus dan IPV2 diintroduksi ke dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023.

Untuk mengukur nilai perlindungan terhadap penyakit-penyakit tersebut pada kelompok bayi usia 0-11 bulan, maka digunakan indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru dengan target 90% pada tahun 2029. Untuk indikator tersebut, jenis imunisasi antigen baru yang diperhitungkan hanya imunisasi PCV dosis kedua dan imunisasi Rotavirus dosis ketiga.

Definisi operasional Indikator cakupan imunisasi antigen baru ada persentase bayi (0 – 11 bulan) yang mendapat 2 dosis imunisasi PCV atau 3 dosis imunisasi rotavirus dengan cara perhitungan jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat 2 dosis imunisasi PCV atau 3 dosis imunisasi RV di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibagi target bayi usia 0-11 bulan dikali 100%

Rumus:

$$\text{cakupan imunisasi antigen baru} = \frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 2 dosis imunisasi PCV atau jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 3 dosis imunisasi rotavirus}}{\text{Bayi usia 0-11 bulan yang menjadi sasaran imunisasi PCV atau Rotavirus}} \times 100$$

3. Cakupan imunisasi HPV

Berdasarkan hasil kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (KIN) atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) beban penyakit akibat PD3I semakin bertambah, diantaranya untuk penyakit kanker serviks, pneumonia, penyakit campak dan rubela, dan penyakit diare. Insiden untuk penyakit-penyakit tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, KIN merekomendasikan untuk melakukan pengenalan antigen imunisasi baru yaitu imunisasi HPV. Imunisasi HPV diperlukan dalam upaya pencegahan penyakit kanker leher rahim. Oleh karena itu, pemberian imunisasi HPV menjadi salah satu strategi dalam eliminasi kanker leher rahim yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim. Imunisasi HPV juga menjadi indikator yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Imunisasi HPV diintroduksi ke dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023. Untuk mengukur perlindungan terhadap penyakit kanker leher rahim pada anak usia sekolah dasar, maka digunakan indikator cakupan imunisasi HPV dengan target 90% setiap tahunnya.

Definisi operasional indikator cakupan imunisasi HPV adalah persentase anak perempuan usia kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat yang sudah mendapatkan imunisasi HPV dengan cara perhitungan adalah jumlah anak perempuan usia sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat mendapatkan imunisasi HPV di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibagi target anak perempuan usia sekolah kelas 5 SD/ sederajat dikali 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rumus:

$$\text{cakupan imunisasi HPV} = \frac{\text{Jumlah anak perempuan usia sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat mendapatkan imunisasi HPV di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah anak perempuan usia sekolah kelas 5 SD/ sederajat}} \times 100$$

4. Cakupan imunisasi lengkap pada baduta

Imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Anak usia bawah dua tahun (baduta) merupakan bagian dari kelompok anak balita yang merupakan salah satu kelompok rentan dan berisiko tinggi untuk tertular penyakit, antara lain Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Pergeseran paradigma imunisasi lengkap pada seorang anak, yang semula cukup hanya dengan imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap, dimana seorang anak harus mendapatkan imunisasi bayi secara lengkap, diteruskan dengan imunisasi pada usia bawah dua tahun (baduta). Pemberian imunisasi pada anak baduta sangat penting, karena berdasarkan hasil kajian Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), titer antibodi beberapa antigen (difteri, pertusis, dan campak rubella) sudah mengalami penurunan pada usia 18 bulan, sehingga seorang anak akan menjadi rentan dari penyakit- penyakit tersebut meskipun sudah melengkapi imunisasi pada saat bayi. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan imunisasi seorang anak pada usia 18 bulan hingga sebelum berusia 24 bulan (23 bulan 29 hari) untuk meningkatkan perlindungan optimal dari PD3I khususnya difteri, pertusis, dan campak rubella.

Definisi operasional cakupan imunisasi lengkap pada baduta adalah persentase anak usia 12-23 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi baduta lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dengan cara perhitungan jumlah anak usia 12 - 23 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi baduta lengkap dibagi target anak usia 12 – 23 bulan dikali 100%

Rumus:

$$\text{Cakupan Imunisasi Lengkap pada Baduta} = \frac{\text{Jumlah anak usia 12 - 23 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi baduta lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah anak usia 12 – 23 bulan}} \times 100\%$$

5. Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar

Definisi operasional cakupan imunisasi di usia sekolah dasar adalah persentase anak usia sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat yang sudah mendapat imunisasi usia sekolah dasar lengkap dengan cara perhitungan jumlah anak usia sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat yang sudah mendapat imunisasi Td 2 dosis dibagi target anak usia sekolah kelas 5 SD/sederajat di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%

6. Cakupan status imunisasi T2+ pada Wanita Usia Subur (WUS)

Pada tahun 2016 Indonesia berhasil mencapai status Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal dan menjadi negara terakhir di Wilayah Regional Asia Tenggara yang divalidasi untuk eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal. Saat ini Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan status eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan status tersebut adalah penguatan imunisasi rutin termasuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada kelompok wanita usia subur (WUS) termasuk ibu hamil. Pada WUS perlu diberikan imunisasi yang mengandung tetanus toxoid sebagai upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap infeksi tetanus serta mengendalikan risiko kematian ibu dan bayi.

Status imunisasi tetanus (status imunisasi T) merupakan jumlah dosis imunisasi yang mengandung tetanus toxoid yang diterima oleh seseorang sesuai dengan interval waktu tertentu. Kekebalan terhadap penyakit tetanus hanya diperoleh melalui imunisasi yang mengandung tetanus toxoid minimal 2 dosis (status imunisasi T2+). Perlindungan jangka panjang diperoleh jika mendapatkan imunisasi yang mengandung tetanus toxoid sebanyak 5 dosis (status imunisasi T5) dengan interval pemberian yang memenuhi syarat. Ibu yang masih memiliki masa perlindungan terhadap tetanus dari vaksin yang mengandung tetanus toxoid yang diperoleh sebelumnya akan memberikan perlindungan terhadap tetanus pada bayi saat lahir.

Untuk mengukur nilai perlindungan terhadap penyakit tetanus pada kelompok ibu hamil dan bayi baru lahir, maka digunakan indikator persentase WUS yang memiliki status imunisasi T2+. WUS yang memiliki status imunisasi T2+ adalah WUS yang mendapat minimal 2 dosis imunisasi yang mengandung tetanus toxoid (status imunisasi T2 – T5).

Definisi operasional cakupan status imunisasi T2+ pada Wanita Usia Subur (WUS) adalah persentase ibu hamil yg sudah memiliki status imunisasi T2+ di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dengan cara perhitungan jumlah ibu hamil yang memiliki status imunisasi T2+ (berdasarkan hasil skrining maupun pemberian imunisasi selama masa kehamilan) dalam kurun waktu 1 tahun dibagi target ibu hamil selama kurun waktu yang sama dikali 100%.

Rumus:

$$\frac{jumlah\ ibu\ hamil\ yang\ memiliki\ status\ imunisasi\ T2+\ dalam\ kurun\ waktu\ satu\ tahun}{jumlah\ ibu\ hamil\ selama\ kurun\ waktu\ yang\ sama}\ x\ 100$$

7. Kabupaten/kota yang mencapai target kinerja surveilans PD3I

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai beberapa target kesehatan global dan regional, yaitu eradikasi Polio pada tahun 2026, eliminasi Campak-Rubela dan Congenital Rubella Syndrome (CRS) pada tahun 2029, serta mempertahankan status eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal yang telah dicapai sejak 2016. Selain itu, pengendalian Difteri dan Pertusis juga menjadi prioritas penting dalam target nasional.

Berdasarkan pemetaan risiko, Indonesia masih termasuk kategori berisiko tinggi untuk Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Hal ini disebabkan oleh cakupan imunisasi yang belum optimal, kinerja surveilans PD3I yang perlu ditingkatkan, serta kendala akses ke fasilitas kesehatan. Tantangan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kasus dan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) PD3I, termasuk KLB Polio yang terjadi pada 2022-2024. Surveilans PD3I yang sensitif terhadap indikator-target merupakan kunci utama dalam pemantauan risiko KLB. Dengan mendeteksi kasus secara dini dan memberikan rekomendasi intervensi yang tepat, jumlah kasus serta luasnya wilayah terdampak dapat diminimalisasi. Beberapa indikator penting yang harus dicapai meliputi:

- Eradikasi Polio: Surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis) yang sensitif, dengan tingkat pelaporan kasus Non Polio-AFP sebesar ≥ 2/100.000 anak usia <15 tahun.
- Eliminasi Campak-Rubela: Surveilans Campak-Rubela yang mencakup tingkat pelaporan kasus discarded (bukan Campak-bukan Rubela) sebesar ≥ 2/100.000 penduduk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Optimalisasi surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) melalui peningkatan sensitivitas serta pencapaian target indikator merupakan langkah strategis untuk mendukung keberhasilan program eradikasi dan eliminasi penyakit, sekaligus pengendalian risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) PD3I di masa depan. Sebagai upaya untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program surveilans PD3I di Indonesia, ditetapkan satu indikator kunci, yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan yang terkait dengan program surveilans PD3I secara nasional. Dengan demikian, peningkatan cakupan dan sensitivitas surveilans di seluruh wilayah menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan.

Definisi Operasional

- Non-Polio AFP (NPAFP) adalah kasus AFP yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil negatif virus polio (non polio).
- Discarded (Bukan Campak-Bukan Rubela) adalah kasus suspek campak yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil negatif campak dan negatif rubela.
- Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I adalah kabupaten/kota yang mencapai target NPAFP rate > 2/100.000 anak usia < 15 tahun dan/atau discarded rate (bukan campak bukan rubella) rate > 2/100.000 populasi

Rumus/Cara Perhitungan

- Non-Polio AFP rate adalah jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan dalam kurun waktu tertentu, dibagi jumlah anak usia <15 tahun, dikali 100.000

$$\frac{jumlah\ kasus\ AFP\ non\ polio\ yang\ dilaporkan}{jumlah\ anak\ usia < 15\ tahun}\ x\ 100.000$$

- Discarded rate adalah jumlah kasus discarded (bukan campak-bukan rubela) yang dilaporkan dalam kurun waktu tertentu, dibagi jumlah penduduk, dikali 100.000

$$\frac{jumlah\ kasus\ discarded\ (bukan\ campak - bukan\ rubela)\ yang\ dilaporkan}{jumlah\ penduduk}\ x\ 100.000$$

- Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I adalah persentase kabupaten/kota yang mencapai target NPAFP rate >2/100.000 anak usia < 15 tahun dan/atau discarded rate (bukan campak bukan rubella) rate > 2/100.000 populasi

$$\frac{jumlah\ kab/kota\ yang\ mencapai\ minimal\ salah\ satu\ target\ NPAFP\ Rate\ atau\ Discarded\ Rate}{jumlah\ seluruh\ kab/kota}\ x\ 100\ \%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.2. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program pada Direktorat Imunisasi tahun 2025-2029 disusun sebagai indikasi kebutuhan anggaran untuk mencapai target indikator kinerja program dan kegiatan yang dijabarkan tiap tahun. Kebutuhan pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan target indikator tahunan serta prioritas penganggaran sesuai prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan. Selaras dengan kebutuhan pendanaan dalam Renstra Kementerian Kesehatan, indikasi kebiutuhan anggaran per program dan kegiatan selama 5 tahun pada Direktorat Imunisasi sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Indikasi pendanaan Direktorat Imunisasi Tahun 2025-2029

Program, Kegiatan	Anggaran (dalam ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029
024.DO - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	**42.130.899**				
6820 - Pengelolaan Imunisasi	42.130.899				
024.DX – Program Pelayanan Kesehatan Primer		**76.030.048**	**84.416.860**	**86.676.760**	**86.633.760**
7955 - Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		559.376	610.000	665.000	680.000
7956 - Penanggulangan Penyakit Menular		75.470.672	83.806.860	86.011.760	85.953.760

Indikasi pendanaan sebagaimana diuraikan diatas belum termasuk indikasi pendanaan yang bersumber hibah langsung luar negeri dan dukungan pembiayaan program imunisasi melalui BOK. Pendanaan hibah langsung luar negeri belum dapat diperkirakan besarannya mengingat prosesnya pendanaanya dilakukan pada tahun berjalan secara tahunan. Demikian juga untuk pembiayaan melalui DAK belum dapat diperkirakan mengingat DAK Jangka Menengah juga belum ditetapkan dasar hukumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Imunisasi 2025–2029 disusun sebagai dokumen strategis dan operasional untuk mengarahkan pelaksanaan program imunisasi secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini memuat fokus intervensi pada peningkatan cakupan imunisasi dan penguatan surveilans PD3I.

Penyusunan rencana aksi ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Kesehatan untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMN 2025–2029, transformasi sistem kesehatan nasional, serta kontribusi terhadap target pembangunan kesehatan global seperti SDGs. Pelaksanaan rencana aksi ini menuntut kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

Diharapkan dokumen ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program imunisasi di seluruh tingkat pemerintahan. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan berorientasi pada hasil, diharapkan dapat tercapai penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, peningkatan ketahanan sistem kesehatan, serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1. Matriks Kerangka Pendanaan

Program, Kegiatan, KRO, RO	Target					Anggaran (dalam ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
024.DO - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						**42.130.899**				
6820 - Pengelolaan Imunisasi						**42.130.899**				
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	***5***					***531.575***				
U01 - NSPK Pengelolaan Imunisasi (kategori I)	1					39.275				
U02 - NSPK Pengelolaan Imunisasi (kategori II)	4					492.300				
QAH - Pelayanan Publik Lainnya	***69***					***15.158.789***				
001 - Layanan Imunisasi dan Surveilans PD3I (LP-5)	60					10.771.165				
002 - Layanan Imunisasi Lengkap Bayi dan Baduta (LP-5)	8					3.252.824				
005 - Layanan Pelaksanaan Operasional Analisis Risiko dan Respon KLB (LP-5)	1					1.134.800				
QMA - Data dan Informasi Publik	***5***					***4.450.499***				
001 - Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Imunisasi dan Surveilans PD3I dan KIPI (LP-5)	2					1.486.859				
002 - Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Imunisasi Lengkap Bayi dan Baduta (LP-5)	3					2.963.640				
RAB - Sarana Bidang Kesehatan	***6***					***8.682.614***				
001 - Pengadaan Logistik Imunisasi dan PD3I (LP-5)	6					8.682.614				
RCB - OP Sarana Bidang Kesehatan	***1***					***100.000***				
U01 - Pemeliharaan Sistem Informasi Imunisasi (LP-5)	1					100.000				
SCM - Pelatihan Bidang Kesehatan	***472***					***6.592.078***				
001 - Tenaga Terlatih Bidang Imunisasi dan Surveilans PD3I dan KIPI (LP-5)	318					4.247.431				
002 - Tenaga Terlatih Bidang Imunisasi Lengkap Bayi dan Baduta (LP-5)	154					2.344.647				
UAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	***4***					***146.920***				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program, Kegiatan, KRO, RO	Target					Anggaran (dalam ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
001 - Laporan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Imunisasi dan Surveilans PD3I (LP-5)	4					146.920				
UBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	***263***					***6.468.424***				
001 - Daerah Mendapat Monitoring dan Supervisi Imunisasi (LP-5)	263					6.468.424				
024.DX – Program Pelayanan Kesehatan Primer							**76.030.048**	**84.416.860**	**86.676.760**	**86.633.760**
7955 - Penanggulangan Penyakit Tidak Menular							**559.376**	**610.000**	**665.000**	**680.000**
QAH - Pelayanan Publik Lainnya	***-***	***2***	***2***	***2***	***2***	***-***	***341.376***	***350.000***	***375.000***	***380.000***
106 - Layanan Imunisasi HPV	-	2	2	2	2	-	341.376	350.000	375.000	380.000
UBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	***-***	***10***	***10***	***10***	***10***	***-***	***218.000***	***260.000***	***290.000***	***300.000***
102 - Pembinaan Pelaksanaan Imunisasi HPV	-	10	10	10	10	-	218.000	260.000	290.000	300.000
7956 - Penanggulangan Penyakit Menular							**75.470.672**	**83.806.860**	**86.011.760**	**85.953.760**
BAH - Pelayanan Publik Lainnya	***-***	***22***	***22***	***22***	***22***	***-***	***12.961.071***	***17.630.000***	***18.110.000***	***18.560.000***
101 - Layanan Imunisasi	-	22	22	22	22	-	12.961.071	17.630.000	18.110.000	18.560.000
BMA - Data dan Informasi Publik	***-***	***2***	***2***	***2***	***2***	***-***	***532.500***	***622.760***	***722.760***	***822.760***
101 - Data dan Informasi Imunisasi	-	2	2	2	2	-	532.500	622.760	722.760	822.760
DCM - Pelatihan Bidang Kesehatan	***-***	***510***	***510***	***510***	***510***	***-***	***7.526.733***	***5.478.000***	***6.008.000***	***5.040.000***
101 - Pelatihan Bidang Imunisasi	-	510	510	510	510	-	7.526.733	5.478.000	6.008.000	5.040.000
FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	***-***	***175***	***199***	***207***	***203***	***-***	***4.074.560***	***3.810.000***	***4.120.000***	***4.090.000***
101 - Pembinaan Pelaksanaan Imunisasi	-	175	199	207	203	-	4.074.560	3.810.000	4.120.000	4.090.000
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		***5***	***5***	***5***	***5***		***283.675***	***284.100***	***290.000***	***295.000***
U11 - NSPK Pengelolaan Imunisasi (kategori I)	-	4	4	4	4	-	157.100	157.100	160.000	160.000
U12 - NSPK Pengelolaan Imunisasi (kategori II)	-	1	1	1	1	-	126.575	127.000	130.000	135.000
QAH - Pelayanan Publik Lainnya		***55***	***55***	***55***	***55***		***9.371.343***	***12.166.000***	***11.505.000***	***12.135.000***
101 - Layanan Imunisasi Lengkap Bayi dan Baduta	-	13	13	13	13	-	6.579.210	7.680.000	7.130.000	7.330.000
103 - Layanan Surveilans PD3I	-	42	42	42	42	-	2.792.133	4.486.000	4.375.000	4.805.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program, Kegiatan, KRO, RO	Target					Anggaran (dalam ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
QMA - Data dan Informasi Publik		***5***	***5***	***5***	***5***		***389.274***	***470.000***	***490.000***	***615.000***
101 - Data dan Informasi Imunisasi Lengkap Bayi dan Baduta	-	2	2	2	2	-	311.474	390.000	410.000	530.000
102 - Data dan Informasi Surveilans PD3I	-	3	3	3	3	-	77.800	80.000	80.000	85.000
RAB - Sarana Bidang Kesehatan		***8***	***8***	***8***	***8***		***35.242.614***	***38.090.000***	***38.610.000***	***39.170.000***
101 - Pengadaan Logistik Penanggulangan PD3I	-	6	6	6	6	-	8.682.614	10.530.000	11.050.000	11.610.000
102 - Alat dan Bahan Kesehatan Pendukung Imunisasi	-	2	2	2	2	-	26.560.000	27.560.000	27.560.000	27.560.000
RCB - OP Sarana Bidang Kesehatan	***-***	***1***	***1***	***1***	***1***	***-***	***106.000***	***106.000***	***106.000***	***106.000***
101 - Pemeliharaan Sistem Informasi Imunisasi	-	1	1	1	1	-	106.000	106.000	106.000	106.000
SCM - Pelatihan Bidang Kesehatan	***-***	***236***	***236***	***236***	***236***	***-***	***2.526.052***	***2.370.000***	***2.410.000***	***2.460.000***
101 - Pelatihan Bidang Imunisasi Lengkap Bayi dan Baduta	-	236	236	236	236	-	2.526.052	2.370.000	2.410.000	2.460.000
UBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		***98***	***98***	***98***	***98***		***2.456.850***	***2.780.000***	***3.640.000***	***2.660.000***
101 - Pembinaan Pelaksanaan Imunisasi Lengkap bayi dan Baduta	-	56	56	56	56	-	1.364.600	1.700.000	1.750.000	1.820.000
103 - Pembinaan Pelaksanaan Surveilans PD3I	-	42	42	42	42	-	1.092.250	1.080.000	1.890.000	840.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Program

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian (Tahun)
1	Rancangan Regulasi Mengenai Penyelenggaraan Imunisasi	Regulasi mengenai Penyelenggaraan Imunisasi merupakan tindak lanjut delegasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi mengenai Penyelenggaraan Imunisasi disusun untuk mendukung Tujuan 1 Renstra yaitu masyarakat sehat di setiap siklus hidup. Regulasi mengenai Penyelenggaraan Imunisasi disusun untuk mendukung sasaran strategis 1.1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotive dan preventif Regulasi mengenai Penyelenggaraan Imunisasi memuat substansi antara lain: - Jenis dan jadwal imunisasi - Penyelenggaraan imunisasi - Pengelolaan sumber daya dan logistik imunisasi - Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi - Penelitian dan Pengembangan - Peran Serta Masyarakat - Pencatatan dan Pelaporan - Pembinaan dan Pengawasan - Pemantauan dan Evaluasi - Surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Agama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kemenko PMK Kemen Komdigi BKKBN Organisasi profesi Ormas Organisasi keagamaan Komli Mitra pembangunan	2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3. Definisi Operasional (DO) dan Cara Perhitungan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional (DO)	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Cakupan imunisasi MR 1 pada bayi	Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi MR 1 di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi MR 1 di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan target bayi usia 0-11 bulan dikali 100%	Data rutin program
2	Cakupan imunisasi antigen baru	Persentase bayi (0 – 11 bulan) yang mendapat 2 dosis imunisasi PCV atau 3 dosis imunisasi rotavirus	Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat 2 dosis imunisasi PCV atau 3 dosis imunisasi RV di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibagi target bayi usia 0-11 bulan dikali 100%	Data rutin program
3	Cakupan imunisasi HPV	Persentase anak perempuan usia kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat yang sudah mendapatkan imunisasi HPV	Jumlah anak perempuan usia sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat mendapatkan imunisasi HPV di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibagi target anak perempuan usia sekolah kelas 5 SD/ sederajat dikali 100%	Data rutin program
4	Cakupan imunisasi lengkap pada baduta	Persentase anak usia 12 - 23 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi baduta lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu	Jumlah anak usia 12 - 23 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi baduta lengkap dibagi target anak usia 12 – 23 bulan dikali 100%	Data rutin program
5	Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	Persentase anak usia sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat yang sudah mendapat imunisasi usia sekolah dasar lengkap	Jumlah anak usia sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat yang sudah mendapat imunisasi Td 2 dosis dibagi target anak usia sekolah kelas 5 SD/sederajat di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	Data rutin program
6	Cakupan status imunisasi T2+ pada Wanita Usia Subur (WUS)	Persentase ibu hamil yg sudah memiliki status imunisasi T2+ di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ibu hamil yang memiliki status imunisasi T2+ (berdasarkan hasil skrining maupun pemberian imunisasi selama masa kehamilan) dalam kurun waktu 1 tahun dibagi target ibu hamil selama kurun waktu yang sama dikali 100%	Data rutin program
7	Kabupaten/kota yang mencapai target kinerja surveilans PD3I	Persentase kabupaten/kota yang mencapai target NP AFP rate >2 per 100.000 anak usia<15 tahun dan/atau discarded rate (bukan campak bukan rubela) rate >2 per 100.000 populasi	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai minimal salah satu target NP AFP rate ≥ 2 per 100.000 anak usia < 15 tahun atau discarded rate ≥ 2 per 100.000 populasi dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikali 100%	Data rutin program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4. Tim Penyusun

KONTIRUBUTOR:
dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M; dr. Indri Yogyaswari, M.A.R.S

EDITOR:
dr. Gertrudis Tandy, MKM, dr. Endang Budi Hastuti, MKM, dr. Sulistya Widada, Ade Frisma Pratama SE, M.AP

SEKRETARIAT:
Vivi Voronika SKM, M.Kes; dr. Devi Anisiska; Stefanus Darmawan S.Kom; Renitha Hertadiningtyas, SE; Damar Vergiyantoro, S.Ak; Laila Kusumawati, S.I.P. Andini Wisdhanorita, SKM, M.Epid; Rita Yulihane, SKM, M.Epid; Indah Hartati, SKM, MKM; Novie Ariani, SKM, M.Epid

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).